

肝硬化合并细菌性腹膜炎时仅 62% 发热, 60% 腹压痛及 42% 反跳痛相仿。肝硬化腹水伴发热、腹部压痛及反跳痛则不一定是合并细菌性腹膜炎。本组肝硬化腹水病人伴有发热 11 例, 腹部压痛 4 例伴反跳痛 2 例, 但皆无腹膜炎证据。

肝硬化腹水合并细菌性腹膜炎时, 腹水中的白细胞计数仍是诊断肝硬化合并细菌性腹膜炎最敏感的指标。当腹水的 $WBC \geq 500/mm^3$, 多形核白细胞 $\geq 250/mm^3$, 敏感性 100%, 准确性 83~92%。但腹水中的白细胞受诸多因素影响。如利尿后腹水中的白细胞可升高, 也可因腹水增多而稀释, 也可因肝硬化脾功能亢进而使白细胞减少。从而使腹膜炎病人漏诊增加。刘敏川报告 100 例细菌培养阳性的肝硬化合并细菌性腹膜炎的病例, 如按全国诊断标准则 64% 病例漏诊。因此寻找更敏感的检查方法, 就能提

高肝硬化合并细菌性腹膜炎的诊断率。

CRP 是一种经典的急性时相蛋白, 由 Tillett 及 Francis 于 1930 年首先在急性肺炎患者血清发现的。因能与肺炎双球菌荚膜的 C 多糖物质起反应, 故命名为 C-反应蛋白。CRP 的合成部位经核素标记技术证实是肝细胞内。除血液外, 其他浆膜腔病变的渗出液(如脑脊液、胸水、腹水)均可查到 CRP。张爱军、黄维国等报告感染性疾病, 特别是细菌性感染性疾病血 CRP 阳性率明显增高, 与非感染性疾病比较有显著的差异, $P < 0.05$ 。本组肝硬化腹水 33 例有 19 例血清 CRP 阳性。其中有明确感染 7 例, 增高原因因为感染及肝硬化肝组织炎症、坏死有一定关系。

总之, 本组结果显示, 肝硬化腹水病人的血清及腹水的 CRP 同时阳性时, 高度提示合并细菌性腹膜炎。

依诺沙星的药物相互作用

徐永昭

依诺沙星(氟啶酸、复克)为第三代氟喹诺酮类抗菌剂, 抗菌谱广、疗效好, 对革兰氏阳性菌和阴性杆菌均具有很强的抗菌作用, 国内产品称复克, 已应用于临床。现将该药物相互作用综述如下。

1 依诺沙星与茶碱

依诺沙星对肝微粒体混合功能氧化酶系统有很强的抑制作用, 使茶碱消除降低, 血药浓度升高, 易引起中毒, 尤其对老年人更易发生, 二者合用时, 茶碱的血药浓度增加 1.5 倍, 60% 的病人可出现不良反应, 其症状为恶心、呕吐、头痛、心动过速等。故二者应禁止同用, 必须合用时, 要小心的监测血内茶碱水平。

2 依诺沙星与咖啡因

依诺沙星对咖啡因的影响与茶碱相似, 能延缓咖啡因转换为副黄嘌呤, 其抑制能力与茶碱相同, 可出现咖啡因中毒症状, 如病人常出现焦虑、不安、失眠、头痛等。故二者合用时, 要减少咖啡因的用量, 并避免服用含咖啡因的食品和饮料。

3 依诺沙星与利福平

利福平是很强的肝药酶诱导剂, 可使依诺沙星的代谢加快, 导致血药浓度降低和治疗失败。有人在实验动物中观察到了这一相互作用, 但在人类尚未见报道。故二者合用时, 一定注意这种潜在的相互作用。

4 依诺沙星与非甾体解热止痛药

动物实验证明, 依诺沙星能阻断抑制性中枢神经介子。氨基丁酸与受体的结合, 产生中枢神经系统兴奋, 有人报道 7 例病人, 依诺沙与芬布芬合用后, 发生了惊厥。文献指出, 除阿斯匹林外, 其它非甾体解热止痛药均可促使依诺沙星诱发惊厥、癫痫、急性脑血管病。小儿应避免二者同服。

5 依诺沙星与抗凝血药

二者同服时, 可使抗凝血过度, 凝血酶原时间延长而致出血。但也有人报道, 有 6 例病人, 接受依诺沙星和法华令治疗的志愿者, 其凝血酶原时间无任何变化, 但依诺沙星是强肝药酶抑制剂, 故二者合用要慎重, 要监测凝血酶原时间的变化。

6 依诺沙星与铝、镁抗酸剂

铝、镁离子可与依诺沙星形成一种不溶性化合物, 使在胃肠道中的吸收减少, 其血浓度可降低至治疗浓度以下, 有人研究证明, 含铝、镁的抗酸剂与依诺沙星合用时, 其血浓度可降低 50%, 故二者应避免合用。

7 依诺沙星与丙磺舒

肾脏可经过两个或更多途径清除依诺沙星, 这提示在其它有机酸存在时, 有增加肾小管分泌作用, 丙磺舒破坏肾小管的分泌而减少尿的回收, 降低依

作者单位: 116011 大连医科大学附属第一医院临床药理学教研室

诺沙星的肾清除率,且不引起药物积蓄,这可能是由于肾小球滤过和肝代谢起了充分的代替作用所致。

8 依诺沙星与雷尼替丁

据文献报道,雷尼替丁 50mg 静注,2 小时后,单剂口服依诺沙星,发现依诺沙星的吸收下降 26~40%,认为是由于雷尼替丁改变了肠道的 PH 值有关,可使疗效降低,二者合用时,应进行监测。

9 依诺沙星与铁剂

铁剂能减少依诺沙星在胃肠道内的吸收,使其抗菌作用降低,其机理不明。有人提出,依诺沙星可能与铁剂形成螯合物,不易被胃肠道吸收所致;有人

报道 12 名正常受试者,单剂口服依诺沙星 400mg,与铁剂(铁—甘氨酸—硫酸盐制剂)200mg 同服后,依诺沙星的生物利用度可下降 36%。

10 依诺沙星与胃复安

胃复安能加快胃肠道蠕动,加速胃排空,与依诺沙星合用时,可促进其进入肠道,从而可增加依诺沙星的吸收,使疗效加强。

11 依诺沙星与乙胺丁醇

依诺沙星与抗结核药乙胺丁醇合用时,使 76% 的分枝杆菌分离株敏感,28% 具有协同的抑制作用。

吗导敏短、长期治疗劳力型心绞痛疗效观察

叶作霖

吗导敏(MoLsidomine)治疗劳力型心绞痛,国内研究报道不多。笔者自 1987 年以来应吗导敏对 21 例典型冠心病劳力型心绞痛患者进行短期和长期治疗,通过治疗前后心电图和收缩时间间期(ST-T)对评价该药对心肌缺血和左室功能受损的临床疗效。

1 对象和方法

患者 21 例,男 19 例,女 2 例,年龄 51~72 岁(平均 58 岁)。全部病例均根据病史及心电图、超声心动图等检查确诊为典型冠心病劳力型心绞痛。心绞痛反复发作史 1~7(平均 3.5)年。治疗前平静心电图或踏车运动后心电图 J 点后 0.08 秒处下移 0.075~0.3mu,伴有 T 波低平或倒置,射血前期/射血时间(PEP/2VET)比值 0.44~0.58(平均 0.49),口服吗导敏 2mg,每日 3 次,服药持续时间 2 例为 4 周,19 例达 16 周。服吗导敏期间停用一切其他扩血管或影响心脏的药物。服药前和服药后 2、4、8、16 周分别描记运动前后心电图,同时用日产 NK-4103 型 3 道式心电图仪测定 ST-T,计算 PEP/LVET 比值。

2 结果

全部病人经短期治疗(服药 4 周)服药前后比较,每周心绞痛发作次数平均从 3.4 减少至 1.3 次,ST 段下移程度平均减轻 69%,PEP/LVET 比值平均从 0.49 缩小至 0.38。以上各项 P 均 < 0.05。

19 例病人经长期治疗,服药 16 周,服药前后比较,每周心绞痛发作次数平均从 3.4 减少至 0.1 次,ST 段下移程度 89%。PEP/LVET 比值平均从 0.49 缩小至 0.30。以上各项 P 均 < 0.01。

分别对此长期治疗与短期治疗后的每周心绞痛发作次数,ST 段下移程度及 PEP/LVET 比值,均有显著性差异(P < 0.57 见表),表明长期治疗效果明显优于短期治疗。18 例病人(88%)服药前有 T 波倒置,长期治疗后恢复直立。2 例病人(男女各一,住院号 867,1022)经长期治疗后,未再服其他扩血管药物,随访两年,无心绞痛发作,一般情况良好,服药期间除 2 例有轻微头痛外,其余病人未出现不良反应。

3 讨论

1982 年罗塔赫—埃格尔国际讨论会曾介绍吗导敏的实验研究和临床应用,确认其活性代谢产物 SIN-1 能特异地影响心脏的冠脉血流,认为吗导敏具有扩张狭窄的冠脉,解除冠脉的痉挛,改善冠脉循环的作用,并能降低心脏前负荷,改善冠脉循环的作用,并能降低心脏前负荷,改善心功能。本组患者均冠心病劳力型心绞痛伴不同程度的心功能损害,给吗导敏长期或短期治疗后,每周心绞痛发作次数明显减少,ST 段下移程度明显减轻,PEP/LVET 比值恢复正常,此结果与国外研究报道一致。本文还观察到经治疗后,原有倒置 T 波均呈现不同程度恢复,提示吗导敏能改善心肌复极异常的心电图表现。本组吗导敏用药量较国外(一般 4mg,每日 3 次)为小,但用药时间较长,故仍取得满意疗效,而副作用大为减少,病人易于耐受。

4 结语

小剂量吗导敏治疗劳力型心绞痛,对减轻心肌

作者单位:5111758 广东省东莞市寮步医院